Evaluation du remplissage du guide de gestion du travail d'accouchement (GGTA) dans le service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-OHG) du 1er Janvier au 31 Juin 2024

Nom du présentateur : Dr OUEDRAOGO Issa, MCA en gynécologie-obstétrique

Auteurs et coauteurs : Sib S R, Sanogo M, Dembele A, Dabre P C, Millogo/Traore TDF

Affiliations : Université Lédea Bernard OUEDRAOGO (ULBO)

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Selon l'OMS, on note plus de 140 millions d'accouchements par an
- Complications survenant pendant le travail et l'accouchement sont à l'origine de décès maternels (plus1/3) et néonatals (6-11%).
- D'où nécessaire de surveiller le travail et l'accouchement.
- En vue de faciliter cette surveillance que le GGTA a été conçu en remplacement du partogramme → formation agents aout 2023

Objectif

Étudier l'utilisation du guide de gestion du travail d'accouchement dans le service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya du 1er janvier au 31 juin 2024.

Matériel et méthode(s)

- étude transversale à visée descriptive, avec collecte rétrospective des données allant du 1er janvier au 31 juin 2024
- Population cible :
  - GGTA des patientes ayant accouchées dans le service
  - sages femmes et maïeuticiens utilisant le GGTA

Matériel et méthode(s)

- Critères inclusion :

  - ensemble des GGTA des patientes ayant accouchées par voie basse.
  - sages femmes et maïeuticiens utilisant le GGGTA et consentants à l'étude.

Matériel et méthode(s)

- Données collectées ont été enregistrées et analysées sur un ordinateur à l'aide du logiciel open source EPI info version 7.2.6.
- Graphiques ont été réalisés avec le logiciel Microsoft Excel 2021.
- Confidentialité des données collectées ont été préservées en gardant l'anonymat.

Résultats

- Taux d'utilisation du guide de gestion du travail d'accouchement pendant période d'étude a été de 61,67% (767 GGTA/1247 accouchements par voie basse)

Résultats

- Sur les 767 GGTA utilisés, 25 ont été correctement remplis, soit un taux de remplissage correct de 3,26%.
- Remplissage correct = remplissage de tous items des différentes sections du GGTA

Résultats

- Section 1 : Taux remplissage correct de 4,04%.

Différents champs	Effectif d'utilisation	Pourcentage
Formation sanitaire	635	82,79
Numéro de dossier	311	40,55
Date d'admission	570	74,32
Nom et prénom	711	92,70
Age	703	91,66
Gestité/Parité	699	91,13
Travail	628	81,88
Diagnostic de la phase active	66	8,6
Rupture des membranes	127	16,56
Pathologies antérieures ou actuelles	225	29,34
Heure	708	92,31

Résultats

- Section 2 (soins de soutien) : Taux remplissage correct de 45,02%

Différents éléments	Effectif	Pourcentage
Accompagnant	526	68,58
Soulagement de la douleur	503	65,58
Liquide per os	502	65,45
Posture	371	48,37

Résultats

- Section 3 (bien être fœtal) : Taux remplissage correct 16,82%

Différents champs	Effectif	Pourcentage
Rythme cardiaque fœtale	434	56,58
Ralentissement du RCF	247	32,20
Liquide amniotique	380	49,54
Variété de la présentation de la tête	536	69,88
Bosse séro-sanguine	559	72,88
Modelage de la tête	521	67,93

Résultats

- Section 4 (bien être mère) : Taux remplissage correct 56,58%

Différents champs	Effectif	Pourcentage
Pouls	661	86,18
Tension artérielle	648	84,49
Température	648	84,49
Urines	462	60,23

Résultats

- Section 5 (Progression travail) : Taux remplissage correct 49,02%

Différents champs	Effectif	Pourcentage
Contractions/10 min	418	54,50
Durée des contractions	419	54,63
Dilatation du col	711	92,70
Descente de la tête	678	88,40

Résultats

- Section 6 (Médicament) : Taux remplissage correct 40,68%

Différents champs	Effectif	Pourcentage
Ocytocine	360	46,94
Médicaments	370	48,24
Liquide IV	389	50,72

Résultats

- Section 7 (Prise décision partagée) : Taux remplissage correct

37,94%

Différents champs	Effectif	Pourcentage
Evaluation	699	91,13
Plan de soin	696	90,74
Nom et prénom du prestataire	298	38,85

Conclusion

- Guide a été utilisé dans la majorité des accouchements avec un taux de remplissage correct qui reste faible.
- Des efforts restent à faire dans le remplissage correct des items des sections 1, 3 et 7
- Amélioration remplissage passe par formation continue, renforcement plateau technique, la supervision prestataires

Merci pour votre attention